



Revue générale des hémorragies gastro-intestinales

Par **Parswa Ansari**, MD, Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York

Reviewed By **Minhhuyen Nguyen**, MD, Fox Chase Cancer Center, Temple University

Vérifié/Révisé juin 2025

Une hémorragie gastro-intestinale peut se produire à un niveau quelconque du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus et être visible ou occulte. Les manifestations dépendent de la localisation et du débit de l'hémorragie. (Voir aussi [Varices](#) et [Lésions vasculaires digestives](#).)

L'**hématémèse** est un vomissement de sang rouge, qui correspond à une hémorragie de la partie supérieure de l'appareil digestif, habituellement due à un [ulcère gastroduodénal](#), une [lésion vasculaire](#) ou une [varice](#). Les vomissements "marc de café" sont des vomissements marron foncé, granuleux qui ressemblent au marc de café. Ils résultent de saignements gastro-intestinaux hauts situés qui ont ralenti ou ont cessé, avec conversion, via l'oxydation, de l'hémoglobine rouge au brun de l'hématine par l'acide gastrique.

Les **rectorragies** sont l'évacuation de sang rouge par l'anus, provenant habituellement d'une hémorragie de la partie terminale du tube digestif, mais peuvent résulter également d'une hémorragie importante du tube digestif haut avec accélération du transit intestinal.

Un **méléna** correspond à l'extériorisation de selles noires par l'anus et témoigne généralement d'une hémorragie de la partie supérieure de l'appareil digestif, mais une hémorragie venant de l'intestin grêle ou du côlon droit peut également en être la cause. Environ 100 à 200 mL de sang dans le tube digestif supérieur sont nécessaires pour provoquer un méléna, qui peut persister pendant plusieurs jours après l'arrêt de l'hémorragie. Des selles noires dans lesquelles la recherche de sang occulte est négative peuvent être dues à l'ingestion de fer, de bismuth ou de divers aliments et ne doivent pas être confondues avec un méléna.

Un **saignement chronique occulte** peut provenir de n'importe quelle localisation du tube digestif et est décelable par la réalisation d'un test chimique spécifique dans les selles.

Des **hémorragies aiguës et graves** peuvent également provenir de n'importe quelle localisation du tube digestif. Les patients peuvent présenter initialement des [signes de choc](#). Les patients présentant une cardiopathie ischémique peuvent développer un angor ou un infarctus du myocarde en raison de l'hypoperfusion coronarienne.

Une hémorragie gastro-intestinale chez des patients qui ont une maladie hépatique sous-jacente peut déclencher une [encéphalopathie portosystémique](#) ou un [syndrome hépatorénal](#) (insuffisance rénale secondaire à une insuffisance hépatique).

Étiologie des hémorragies gastro-intestinales

De nombreuses causes existent (voir tableau [Causes fréquentes de saignement gastro-intestinal](#)), et sont classées en fonction de leur origine, tractus digestif haut (au-dessus de l'angle de Treitz), côlon et intestin grêle.

L'hémorragie, quelle qu'en soit la cause, est plus probable et potentiellement plus sévère, en cas d'atteinte hépatique chronique (p. ex., [maladie hépatique alcoolique](#), [hépatite chronique](#)), ou de troubles héréditaires de la coagulation ou de prise de certains médicaments.

Les médicaments associés à une hémorragie gastro-intestinale comprennent les anticoagulants (p. ex., héparine, warfarine, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban), ceux touchant la fonction plaquettaire (p. ex., aspirine et AINS, clopidogrel, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) et ceux qui affectent les défenses de la muqueuse (p. ex., AINS).

TABLEAU

Causes fréquentes de saignement gastro-intestinal

Tractus digestif haut*†

[Ulcère duodéal](#) (15–29%)†

[Ulcère gastrique](#) (14–16%)†

[Varices](#) (5–33%)

[Déchirure de Mallory-Weiss](#) (6–15%)

Érosions gastriques ou duodénales (3–15%)

Œsophagite érosive (2–15%)

Angiome (1–5%)

[Tumeurs stromales gastro-intestinales](#) (1–5%)

[Malformation artérioveineuse](#) (< 5%)

Hémobilie

Tractus digestif bas (les pourcentages varient selon la classe d'âge considérée)

[Fissures anales](#)

Angiodysplasies (ectasie vasculaires)

Colite: radique, ischémique, infectieuse

Cancer du côlon

Polypes coliques

Maladie diverticulaire

Maladie intestinale inflammatoire chronique:
rectocolite ulcéro-hémorragique/maladie de
Crohn

Hémorroïdes internes

Lésions de l'intestin grêle (rare)

Angiomes

Malformations artérioveineuses

Diverticule de Meckel

Tumeurs

* Hwang JH, Fisher DA, Ben-Menachem T, et al;
Standards of Practice Committee of the American
Society for Gastrointestinal Endoscopy. The role of
endoscopy in the management of acute non-variceal
upper GI bleeding. *Gastrointest Endosc.* 2012
Jun;75(6):1132-8. doi: 10.1016/j.gie.2012.02.033;

Kim JJ, Sheibani S, Park S, Buxbaum J, Laine L. Causes
of bleeding and outcomes in patients hospitalized
with upper gastrointestinal bleeding. *J Clin*
Gastroenterol. 2014;48(2):113-118.
doi:10.1097/MCG.0b013e318297fb40

† Les ulcères gastriques et duodénaux combinés
peuvent représenter jusqu'à 50% des saignements
digestifs hauts.

Évaluation des saignements gastro-intestinaux

Chez les patients gravement malades, la stabilisation avec protection des voies respiratoires, remplissage vasculaire IV, ou des transfusions est essentielle avant et pendant les investigations diagnostiques.

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit essayer d'établir la quantité et la fréquence des saignements. Cependant, la quantité peut être difficile à évaluer car même de petites quantités de sang (5 à 10 mL) dans l'eau de la cuvette des toilettes peuvent donner une couleur rouge opaque, et parce que des quantités modestes de sang dans les vomissements peuvent sembler énormes à un patient anxieux. Cependant, on peut le plus souvent distinguer quelques traces de sang, de quelques cuillères à café de sang et de volumineux caillots.

Il faut interroger les patients qui présentent une hématomatose afin de savoir si le saignement était présent dès les premiers vomissements ou après un (ou plusieurs) vomissement alimentaire non sanglant. En outre, le médecin doit poser des questions spécifiques pour distinguer l'hématomatose de l'hémoptysie, car les patients peuvent confondre les deux symptômes.

Il faut interroger les patients qui présentent des rectorragies afin de savoir s'il s'agit de sang frais rouge pur; ou mélangé aux selles, à du pus ou du mucus; ou si les selles étaient simplement recouvertes de filets de sang ou s'il s'en trouvait sur le papier toilette. Il faut interroger ceux présentant une diarrhée sanglante, sur la notion de voyage ou toute autre situation d'exposition à un agent pathogène.

L'anamnèse ou la **revue des systèmes** doit comprendre la recherche d'une gêne abdominale, d'une perte de poids, de saignements ou d'ecchymoses faciles, des résultats de coloscopies ou d'endoscopies antérieures et des symptômes d'anémie (p. ex., asthénie, fatigabilité, vertiges).

La **recherche des antécédents médicaux** doit comprendre les saignements gastro-intestinaux antérieurs (diagnostiqués ou non); les maladies intestinales inflammatoires chroniques connues, les troubles de l'hémostase et les maladies hépatiques; et l'utilisation de médicaments ou de substances qui peuvent augmenter la probabilité de saignement ou de maladie hépatique chronique (p. ex., l'alcool).

Examen clinique

L'examen général se concentre sur les constantes vitales et sur tout autre signe de **choc ou d'hypovolémie** (p. ex., tachycardie, tachypnée, pâleur, diaphorèse, oligurie, confusion) et les signes d'anémie (p. ex., pâleur, sueurs). Les patients qui présentent des saignements moins importants peuvent simplement présenter une tachycardie modérée (fréquence cardiaque > 100) ou aucun signe.

Une hypotension orthostatique (une chute de > 20 mmHg systolique ou 10 mmHg diastolique) avec une augmentation concomitante de la fréquence cardiaque se développe souvent après une perte aiguë de > 2 unités de sang. Cependant, les mesures orthostatiques sont peu adaptées en cas d'hémorragie sévère car elles peuvent entraîner une syncope et sont peu sensibles et spécifiques pour mesurer la volémie en cas d'hémorragie modérée, en particulier chez le sujet âgé.

Les stigmates extérieurs des troubles hémorragiques (p. ex., pétéchies, ecchymoses) sont recherchés, ainsi que des signes de maladie chronique du foie (p. ex., angiomes stellaires, ascite, érythème palmaire) et d'hypertension portale (p. ex., splénomégalie, circulation veineuse collatérale abdominale).

Un toucher rectal est nécessaire pour définir la couleur des selles, et rechercher une masse anorectale. L'anuscopie est effectuée afin de diagnostiquer les hémorroïdes. Les tests chimiques de recherche spécifique de sang occulte dans les selles peuvent terminer l'examen lorsque le sang n'est pas macroscopiquement présent.

Signes d'alarme

CALCULATEUR CLINIQUE

[Score ABC pour la prédiction de la mortalité à 30 jours en cas de saignement gastro-intestinal aigu](#)



Plusieurs signes suggèrent une hypovolémie significative ou un choc hémorragique:

- Syncope
- Hypotension
- Pâleur
- Transpiration
- Tachycardie
- Oligurie

Le score ABC utilise l'âge; les taux d'urée, d'albumine et de créatinine; la présence d'un état mental altéré, d'une cirrhose, d'un cancer disséminé; et le score de l'American Society of Anesthesiologists pour prédire la mortalité à 30 jours dans les saignements digestifs hauts et bas ([1](#)).

Interprétation des signes

L'anamnèse et l'examen clinique suggèrent une origine au saignement chez de nombreux patients, mais les examens complémentaires sont généralement nécessaires.

Une gêne abdominale épigastrique soulagée par l'alimentation ou les antiacides évoque un [ulcère gastroduodénal](#). Cependant, dans de nombreux cas d'hémorragie ulcéreuse, on ne retrouve pas d'antécédents douloureux.

Une perte de poids et une anorexie, avec ou sans anomalie des selles, suggèrent un cancer digestif.

Des antécédents de cirrhose ou d'hépatite chronique évoquent des [varices œsophagiennes](#). Une [dysphagie](#) évoque un cancer ou une [sténose de l'œsophage](#). Des vomissements ou des efforts de vomissements avant le début de l'hémorragie évoquent une [déchirure de Mallory-Weiss](#) de l'œsophage, bien que tous les patients qui ont des déchirures de Mallory-Weiss ne présentent pas ces antécédents.

Un antécédent d'hémorragie (p. ex., purpura, ecchymose, hématurie) peut évoquer une [diathèse hémorragique](#) (p. ex., hémophilie, insuffisance hépato-cellulaire).

Une diarrhée sanglante, fébrile et des douleurs abdominales suggèrent une [colite ischémique](#), une [maladie intestinale inflammatoire](#) (p. ex., [rectocolite ulcéro-hémorragique](#), [maladie de Crohn](#)) ou une

colite infectieuse (p. ex., [Shigella](#), [Salmonella](#), [Campylobacter](#), [amibiase](#)).

Des rectorragies évoquent une [diverticulose](#) colique ou des [angiodysplasies](#). Du sang frais sur le papier toilette ou à la surface des selles formées suggère des [hémorroïdes internes](#) ou une [fissure](#), alors que du sang mélangé aux selles indique une source plus proximale. La présence de sang occulte dans les selles peut être le premier signe d'un [cancer du côlon](#) ou d'un [polype](#), en particulier chez le malade > 45 ans.

La présence de sang dans le nez ou coulant vers le bas du pharynx, évoque une épistaxis comme origine de l'hémorragie.

La présence d'angiomes stellaires, d'hépatosplénomégalie, d'ascite, suggère une hépatopathie chronique et donc de probables varices œsophagiennes. Des malformations artérioveineuses, en particulier des muqueuses, suggèrent une [télangiectasie hémorragique héréditaire](#) (syndrome de Rendu-Osler-Weber). Les télangiectasies de la matrice de l'ongle, de la peau et du tractus gastro-intestinal peuvent être le signe d'une [sclérodermie](#) ou d'une [connectivite mixte](#).

Examens complémentaires

Plusieurs tests sont effectués pour confirmer le diagnostic suspecté:

- Numération formule sanguine, profil de coagulation et souvent autres examens sanguins
- La mise en place d'une sonde nasogastrique sauf pour les saignements minimes rectaux
- Endoscopie digestive haute en cas de suspicion d'hémorragie gastro-intestinale du tractus digestif haut
- Coloscopie pour les causes basses (non clairement provoquées par des hémorroïdes)
- Parfois, angiographie pour saignement gastro-intestinal haut et bas

Une **NFS** doit être pratiquée en cas de perte de sang de gros volume ou occulte. Les patients qui présentent des saignements plus importants doivent également subir des examens de la coagulation (p. ex., numération plaquettaire, temps de prothrombine [temps de Quick (TQ)], temps partiel de thromboplastine [= TPP, TCK, TCA, TPP]) et des examens hépatiques (p. ex., bilirubine, phosphatase alcaline, albumine, aspartate aminotransférase [AST], alanine aminotransférase [ALT]). Une détermination de groupe sanguin et une épreuve de compatibilité (cross match) sont effectuées si un saignement est en cours. L'hémoglobine et l'hématocrite peuvent être répétés jusqu'à toutes les 6 heures en cas d'hémorragies sévères.

Une **aspiration nasogastrique** et un lavage gastrique doivent être pratiqués chez tout patient suspecté d'hémorragie digestive haute (p. ex., hématomèse, vomissements noirâtres, méléna, hémorragies rectales massives). La présence de sang dans l'aspiration nasogastrique indique une hémorragie digestive haute active, mais jusqu'à 15% des patients présentant une hémorragie des voies digestives supérieures n'ont pas de sang dans l'aspiration nasogastrique (2). La présence de sang noir digéré indique une hémorragie lente ou arrêtée. S'il n'y a aucun signe de saignement, et que de la bile est ramenée, la sonde nasogastrique est retirée; sinon, elle est laissée en place pour contrôler le saignement qui peut être continu ou récurrent. Un aspirât non sanglant, non bilieux est considéré comme une aspiration non diagnostique.

Une **endoscopie digestive haute** (examen de l'œsophage, de l'estomac et du duodénum) doit être pratiquée en cas d'hémorragie digestive haute. L'endoscopie pouvant être thérapeutique autant que diagnostique, elle doit être pratiquée rapidement en cas d'hémorragie importante, mais peut être reportée de 24 heures si l'hémorragie s'arrête ou si elle est minime. Le transit baryté œso-gastro-duodénal n'a aucune indication dans l'hémorragie aiguë et le contraste utilisé peut obscurcir ultérieurement les tentatives d'angiographie.

Une **sigmoïdoscopie flexible et une anoscopie** rigide sont les seuls examens nécessaires à court terme devant des symptômes caractéristiques d'hémorragie hémorroïdaire. Tous les autres patients qui présentent une rectorragie doivent subir une **coloscopie** qui peut être réalisée après une préparation standard, sauf en cas d'hémorragie importante et persistante. Chez ces patients, une préparation rapide (5 à 6 L de solution de polyéthylène glycol délivrée par sonde nasogastrique ou par la bouche en 3 à 4 heures) permet souvent une visualisation adéquate.

Les directives 2023 de l'American College of Gastroenterology [guidelines on management of patients with acute lower GI bleeding](#) suggèrent l'**angiographie par TDM** comme test diagnostique initial chez les patients présentant une hématochézie hémodynamiquement significative en cours (3). Si l'angiogramme par TDM est positif, l'**angiographie transcathéter** ou la **coloscopie** sont des options thérapeutiques. La scintigraphie aux radionucléides est disponible à des fins diagnostiques lorsque l'angiographie par TDM est contre-indiquée ou non disponible.

Angio-TDM montrant un saignement gastro-intestinal

IMAGE



Ces images montrent les images d'angiographie TDM d'hémorragies aiguës gastro-intestinales provenant d'un diverticule du côlon droit. L'image en haut à gauche montre une vue sans contraste. L'image en haut à droite montre la phase artérielle avec un produit de contraste extravasé à l'intérieur des diverticules (flèche). L'image en bas à gauche montre la phase portale avec une augmentation du blush dans la lumière colique (flèches). L'image en bas à droite montre la projection coronale à intensité maximale correspondante (flèche).

© SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA

Le diagnostic d'hémorragie occulte peut être difficile, car elle peut résulter d'hémorragies situées n'importe où dans le tube digestif. L'endoscopie est la méthode diagnostique de choix dans ce cas, les symptômes déterminent si la partie supérieure ou inférieure du tube digestif doit être examinée en premier. Le lavement baryté à double contraste et la sigmoïdoscopie peuvent être utilisés pour la partie inférieure du tube, lorsque la coloscopie n'est pas possible ou est refusée par le patient.

Si les résultats de l'endoscopie haute et de la coloscopie sont négatifs et que du sang occulte est toujours présent dans les selles, un TOGD avec opacification de tout l'intestin grêle, une endoscopie de l'intestin grêle (entéroscopie), une entérographie TDM, une endoscopie par capsule (qui utilise une petite caméra en forme de pilule qui est avalée), une scintigraphie aux globules rouges ou aux colloïdes marqués au technétium, et une angiographie doivent être envisagés. L'endoscopie par capsule a une valeur limitée chez un patient qui saigne activement.

Références pour l'évaluation

1. [Laurson SB, Oakland K, Laine L, et al.](#) ABC score: a new risk score that accurately predicts mortality in acute upper and lower gastrointestinal bleeding: an international multicentre study. *Gut*. 2021;70(4):707-716. doi:10.1136/gutjnl-2019-320002
2. [Hwang JH, Fisher DA, Ben-Menachem T, et al; Standards of Practice Committee of the American Society for Gastrointestinal Endoscopy.](#) The role of endoscopy in the management of acute non-variceal upper GI bleeding. *Gastrointest Endosc*. 2012 Jun;75(6):1132-8. doi: 10.1016/j.gie.2012.02.033
3. [Sengupta N, Feuerstein JD, Jairath V, Shergill AK, Strate LL, Wong RJ, Wan D.](#) Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding: An Updated ACG Guideline. *Am J Gastroenterol*. 2023 Feb 1;118(2):208-231. doi: 10.14309/ajg.0000000000002130

Traitement des hémorragies gastro-intestinales

- Une protection des voies respiratoires sûre si nécessaire
- Réanimation par remplissage vasculaire IV
- Transfusion sanguine si nécessaire
- Parfois, médicaments
- Dans certains cas, hémostase endoscopique ou angiographique

L'hématémèse, les rectorragies ou le méléna doivent être considérés comme des urgences potentielles. L'admission en USI ou d'autres environnements contrôlés incluant une consultation par un chirurgien et un gastro-entérologue dans le même temps, est recommandée chez tout malade présentant une hémorragie digestive importante.

Le traitement général vise à maintenir la perméabilité des voies respiratoires et à restaurer la volémie (1-4). L'hémostase et les traitements à entreprendre dépendent de la cause du saignement.

Voies respiratoires

Une cause majeure de morbidité et de mortalité en cas d'hémorragie active du haut appareil digestif est l'inhalation de sang et les complications respiratoires qui s'ensuivent. Pour éviter ces troubles, l'intubation endotrachéale doit être envisagée chez les patients dont le réflexe pharyngé est aboli ou chez les patients présentant des troubles de la conscience, en particulier s'ils ont besoin d'une endoscopie digestive haute.

Réanimation liquidienne et transfusion de produits sanguins

L'accès intraveineux doit être obtenu immédiatement. Les cathéters courts, de gros calibre (p. ex., calibre 14 à 16) IV dans les veines antécubitales sont préférables à un cathéter veineux central, sauf si une grande (8,5 French) gaine est utilisée. Les liquides IV sont commencés immédiatement, comme chez tout patient présentant une hypovolémie ou un choc hémorragique (voir [Réanimation volémique intraveineuse](#)). On administre aux adultes sans comorbidités du sérum physiologique IV à la dose de 500 à 1000 mL, jusqu'à ce que les signes d'hypovolémie disparaissent, jusqu'à un maximum de 2 L (chez l'enfant 20 mL/kg, qui peuvent être répétés 1 fois).

Le patient nécessitant plus de réanimation doit recevoir une transfusion de culots globulaires. Les transfusions se poursuivent jusqu'à ce que la volémie soit restaurée, puis sont administrées au besoin pour remplacer les pertes sanguines. Les transfusions chez les patients âgés ou chez les coronaropathes peuvent être arrêtées lorsque l'hémoglobine est stable à 8 g/dL (80 g/L), à moins que le patient ne soit symptomatique. Les patients plus jeunes ou ceux présentant une hémorragie chronique ne sont généralement pas transfusés, sauf si l'hémoglobine est à < 7 g/dL (70 g/L) ou s'ils présentent des symptômes tels que la dyspnée ou l'ischémie coronaire.

La numération plaquettaire doit être surveillée de près; une transfusion plaquettaire peut être nécessaire au cours des hémorragies sévères. Le patient qui prend des médicaments antiagrégants (p. ex., clopidogrel, aspirine) souffre d'un dysfonctionnement plaquettaire, entraînant souvent une hémorragie accrue. Une transfusion de plaquettes peut être considérée lorsque le patient qui prend ces médicaments a une hémorragie continue grave, bien que les médicaments circulants résiduels (en particulier le clopidogrel) puissent inactiver les plaquettes transfusées. Si les patients prennent un antiplaquettaire ou un anticoagulant pour une indication cardiovasculaire récente, un cardiologue doit être consulté si possible, avant d'arrêter le médicament, d'inhiber le traitement ou de pratiquer une transfusion de plaquettes.

Si une transfusion sanguine importante est nécessaire, du plasma frais congelé et des plaquettes doivent également être transfusés avec des culots de globules rouges conformément aux protocoles de transfusion massifs de l'établissement. Si le patient présente une coagulopathie, une correction par du plasma frais congelé ou du concentré de complexe prothrombinique doit être envisagée.

La décision d'inverser le traitement anticoagulant ou antiplaquettaire d'un patient doit être prise en fonction de l'équilibre entre le risque hémorragique évalué et le risque thrombotique du patient. Les recommandations basées sur les directives concernant l'utilisation de plasma frais congelé, de concentrés de complexe prothrombinique ou d'autres agents de réversion sont limitées en raison d'un manque de preuves ([1,3](#)). La réversion avec du plasma frais congelé peut être envisagée chez un patient présentant une hémorragie menaçant le pronostic vital.

De plus, il existe des données limitées pour guider la reprise du traitement antiplaquettaire après un saignement d'ulcère gastroduodéal. Dans le cas des patients sous double thérapie antiplaquettaire, l'aspirine ne doit pas être interrompue, mais le clopidogrel peut être suspendu pendant environ 7 jours après que l'ulcère hémorragique aura été traité par endoscopie. Dans le cas des patients sous aspirine seule, elle peut être reprise 0 à 3 jours après que l'ulcère hémorragique aura été traité (5).

Médicaments

Un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) IV (p. ex., pantoprazole, ésoméprazole, lansoprazole) peut être débuté en cas de possible hémorragie digestive haute et doit être utilisé si un ulcère gastroduodéal est confirmé comme étant la source du saignement.

L'octréotide, un analogue synthétique de la somatostatine, est utilisé chez les patients chez qui on suspecte un saignement variqueux. L'octréotide est administré sous la forme d'un bolus IV suivi d'une perfusion continue.

L'administration d'acide tranexamique ne semble pas réduire la mortalité, le taux d'intervention ou l'utilisation de produits sanguins dans les saignements digestifs bas, mais elle peut avoir un rôle dans les saignements variqueux (6).

Hémostase

Les hémorragies gastro-intestinales basses se résolvent spontanément chez environ 75% des patients (3). Entre 30 et 60% des patients présentant un saignement digestif haut ne nécessitent pas d'hémostase endoscopique (7,8). Les patients restants nécessitent une forme d'intervention. Le traitement spécifique repose sur le site d'origine de l'hémorragie. L'intervention précoce pour contrôler l'hémorragie est importante pour minimiser la mortalité, en particulier chez les sujets âgés.

En cas d'ulcère gastroduodéal, l'hémorragie active ou une récurrence est traitée par coagulation endoscopique (par électrocoagulation bipolaire, sclérothérapie par injection, sondes thermiques ou clips) (2). La poudre hémostatique peut être utilisée comme agent de temporisation, en particulier pour les ulcères gastroduodéaux ou le cancer. Les vaisseaux visibles dans le fond de l'ulcère, non hémorragiques, sont également traités. Si les traitements endoscopiques n'arrêtent pas le saignement, l'endoscopie haute doit être répétée. Si la réintervention échoue, une embolisation angiographique du vaisseau qui saigne peut être tentée, ou bien une intervention chirurgicale est nécessaire pour suturer le site de saignement. L'embolisation angiographique a un taux de récurrence du saignement plus élevé que la chirurgie, mais a un taux de complications plus faible et permet des hospitalisations plus courtes. Si le patient a été traité médicalement pour un ulcère gastroduodéal mais présente un saignement récurrent, le chirurgien effectue une chirurgie de réduction de l'acidité gastrique dans le même temps (2).

Une hémorragie en cours due à des varices œsophagiennes peut être traitée par ligature endoscopique, injection sclérosante ou une anastomose portosystémique intrahépatique par voie transjugulaire (TIPS, transjugular intrahepatic portosystemic shunting) (9).

Une **hémorragie grave, en cours, de la partie inférieure de l'appareil digestif** due à des diverticules ou à des angiomes peut parfois être contrôlée pendant la coloscopie par des clips, par

électrocautérisation, par coagulation avec une sonde thermique ou par injection d'adrénaline diluée (3). Si ces méthodes sont inefficaces ou impraticables, une angiographie avec embolisation ou infusion de vasopressine peut être efficace. Cependant, les collatéralités vasculaires de l'intestin sont limitées, l'angiographie présente donc un risque d'ischémie ou d'infarctus de l'intestin à moins que l'angiographie soit réalisée par technique de cathétérisme supra-sélectif. Dans la plupart des séries publiées, le taux de complications ischémiques est < 5% (3). La perfusion de vasopressine a un taux de succès élevé pour arrêter l'hémorragie, mais l'hémorragie peut récidiver chez environ 40% des patients (10). Il existe également un risque d'HTA et d'ischémie coronarienne. En outre, l'angiographie peut être utilisée pour localiser la source d'hémorragie plus précisément.

Les polypes peuvent être enlevés par anse diathermique ou par cautérisation.

La **chirurgie** peut être effectuée en cas d'hémorragie continue (nécessitant > 6 unités de transfusion), mais la localisation du site de l'hémorragie est très importante. Si le site du saignement ne peut être localisé, une colectomie subtotala est recommandée. L'hémi-colectomie aveugle (sans identification préopératoire du site de l'hémorragie) présente un risque de récurrence hémorragique plus élevé que lorsque la source de l'hémorragie a été localisée (3). Cependant, le bilan doit être très rapide, de sorte que la chirurgie ne soit pas inutilement retardée. Chez les patients présentant un saignement digestif bas nécessitant une chirurgie, certaines études estiment une mortalité entre 15 et 40% chez ceux qui ont reçu > 10 unités de globules rouges concentrés (11, 12).

Les hémorragies aiguës ou chroniques des hémorroïdes internes s'arrêtent spontanément dans la plupart des cas. Les patients qui présentent des hémorragies réfractaires sont traités lors de l'anuscopie, par ligature élastique, sclérothérapie par injection, coagulation ou par voie chirurgicale.

Références pour le traitement

1. [Abraham NS, Barkun AN, Sauer BG, Douketis J, Laine L, Noseworthy PA, Telford JJ, Leontiadis GI](#). American College of Gastroenterology-Canadian Association of Gastroenterology Clinical Practice Guideline: Management of Anticoagulants and Antiplatelets During Acute Gastrointestinal Bleeding and the Periendoscopic Period. *Am J Gastroenterol*. 2022 Apr 1;117(4):542-558. doi: 10.14309/ajg.0000000000001627
2. [Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Leontiadis GI](#). ACG Clinical Guideline: Upper Gastrointestinal and Ulcer Bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2021 May 1;116(5):899-917. doi: 10.14309/ajg.0000000000001245. Erratum in: *Am J Gastroenterol*. 2021 Nov 1;116(11):2309. doi: 10.14309/ajg.0000000000001506
3. [Sengupta N, Feuerstein JD, Jairath V, et al](#). Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding: An Updated ACG Guideline. *Am J Gastroenterol*. 2023;118(2):208-231. doi:10.14309/ajg.0000000000002130
4. [Gerson LB, Fidler JL, Cave DR, Leighton JA](#). ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2015 Sep;110(9):1265-87; quiz 1288. doi: 10.1038/ajg.2015.246.
5. [Ma H, Fan X, Jiao L, Meng X, Zhao L, Wang J](#). Time of Resumption of Antiplatelet Drugs After Upper Gastrointestinal Hemorrhage. *Med Sci Monit*. 2022 Jul 23;28:e936953. doi: 10.12659/MSM.936953

6. [HALT-IT Trial Collaborators](#). Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding (HALT-IT): an international randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2020 Jun 20;395(10241):1927-1936. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30848-5
7. [Lau JYW, Yu Y, Tang RSY, et al](#). Timing of Endoscopy for Acute Upper Gastrointestinal Bleeding. *N Engl J Med*. 2020 Apr 2;382(14):1299-1308. doi: 10.1056/NEJMoa1912484
8. [Kawaguchi K, Yoshida A, Yuki T, et al](#). A multicenter prospective study of the treatment and outcome of patients with gastroduodenal peptic ulcer bleeding in Japan. *Medicine (Baltimore)*. 2022 Dec 9;101(49):e32281. doi: 10.1097/MD.00000000000032281
9. [Hwang JH, Shergill AK, Acosta RD, et al](#). The role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage. *Gastrointest Endosc*. 80(2):221-227, 2014. doi: 10.1016/j.gie.2013.07.023
10. [Liang HL, Chiang CL, Li MF](#). Empiric embolization by vasospasm therapy for acute lower gastrointestinal bleeding: a preliminary report. *Sci Rep*. 2024 Oct 28;14(1):25728. doi: 10.1038/s41598-024-76408-8
11. [Czymek R, Kempf A, Roblick U, Jungbluth T, Schmidt A, Limmer S, Kujath P, Bruch HP, Fischer E](#). Factors predicting the postoperative outcome of lower gastrointestinal hemorrhage. *Int J Colorectal Dis*. 2009 Aug;24(8):983-8. doi: 10.1007/s00384-009-0695-1
12. [Bender JS, Wiencek RG, Bouwman DL](#). Morbidity and mortality following total abdominal colectomy for massive lower gastrointestinal bleeding. *Am Surg*. 1991 Aug;57(8):536-40; discussion 540-1.

Bases de gériatrie: hémorragie digestive

Chez les personnes âgées, les [hémorroïdes](#) et le [cancer colorectal](#) sont les causes les plus fréquentes d'hémorragie mineure. L'[ulcère gastroduodénal](#), la [maladie diverticulaire](#) et les [angiodyplasies](#) sont les causes les plus fréquentes des saignements graves. Les varices hémorragiques sont moins fréquentes que chez les patients jeunes.

Une hémorragie gastro-intestinale massive est mal tolérée par les sujets âgés. Le diagnostic doit être établi rapidement et le traitement doit être commencé plus tôt que chez les patients plus jeunes, qui peuvent mieux tolérer les épisodes répétés de saignement.

Points clés

- Des rectorragies peuvent résulter d'une hémorragie digestive haute ou basse.
- Les modifications orthostatiques des signes vitaux sont des marqueurs non fiables d'hémorragie grave.
- Une hématomèse, une hématochiaie ou un méléna doivent être considérés comme une urgence potentielle et être pris en charge en unité de soins intensifs ou un autre environnement surveillé.

- La réanimation par perfusion intraveineuse doit commencer immédiatement et peut nécessiter une transfusion de produits sanguins.
- Jusqu'à 75% des patients qui ont un saignement digestif bas et 60% des patients qui ont un saignement digestif haut arrêtent de saigner spontanément; diverses techniques endoscopiques sont habituellement le premier choix pour les autres patients.



Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, États-Unis et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.